Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de São Joaquim do Monte

Pç. Dr Alberto de Oliveira, S/N, Centro, SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE - CEP: 55670-000 - F:(81) 37532970

Processo nº 0000624-62.2023.8.17.3310

AUTOR(A): P. M. S. N.
REPRESENTANTE: ESTEVAO FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO

RÉU: UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SUA SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Vistos.

-

PEDRO MIGUEL SILVA NASCIMENTO, devidamente representado por seu genitor Estevão Felipe dos Santos Nascimento devidamente identificado nos autos do processo em epígrafe, ingressou, por intermédio de advogado regularmente constituído, com a presente **AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS**, em desfavor do **UMINED SERRANA RJ, também conhecida como UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SÉRVIÇOS MÉDICOS E HSOPITALARES LTDA E SUA SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (ACCESS SAÚDE)**, igualmente qualificado.

Alega a parte autora, em síntese, que o requerente é portador de autismo. Pensado na saúde do filho, seu pai contatou uma corretora de plano de saúde, onde aproveitando que o mesmo estava residindo no Rio, lhe aconselhou a contratar a UNIMED SERRANA/RJ com plano nacional, tal contratação se deu em setembro de 2022, tendo desde logo começado o plano. Quando voltou para Pernambuco, o requerente começou a fazer diversas avaliações, onde foi constatado a necessidade de realização de várias terapias e tratamentos através da clinica CRN em Caruaru, o médico foi enfático ao informar a necessidade de tais tratamentos de maneira corriqueira e em caráter indeterminado. E um tratamento extremamente caro que o requerente só tem condições de realizar em virtude da contratação do plano de saúde. Começou o tratamento na modalidade reembolso, onde o genitor do requerente pagava os valores e a UNIMED ressarcia. O requerente sempre pagou prontamente o plano de saúde que no começo era no valor de R$ 391,07 (trezentos e noventa e um reais e sete centavos) posteriormente sofrendo reajuste e passando a ser R$

543,59. Porém, em setembro desse ano o genitor do requerente recebeu um e-mail que lhe deixou consternado, o qual informa que o contrato do autor será excluído por cancelamento de contrato pelas duas requeridas SEM MOTIVO APARENTE, no dia 30/09/2023. Destaca-se que no e-mail embora a requerida afirme que será possível realizar a portabilidade do plano nos moldes da ANS, o genitor do demandante ligou para a demandada onde foi lhe informado que não há a possibilidade de fazer portabilidade, sendo necessário a contratação de um novo plano, ou seja, perdendo a carência que já possui e por consequência atrasando o tratamento do autor. O plano de saúde do requerente será cancelado sem motivo aparente, mesmo o demandante está em dia com suas obrigações. A carteirinha do autor no entanto monstra validade até o ano de 2032. O requerente ligou para a UNIMED, primeira requerida da demanda, onde lhe foi informado que o mesmo poderia continuar como beneficiário do plano diretamente com a UNIMED sem o intermédio da segunda requerida, porém, para isso se faz necessário a portabilidade do plano, o que ambas se negam a fazer.

Em tutela de urgência requer o restabelecimento do plano de saúde e sua continuidade do tratamento na clínica CNR e ao final, requereu a confirmação da liminar e a condenação em danos morais. (ID 144492203).

Juntou documentos.

Decisão concedendo a liminar, deferindo a gratuidade da justiça e determinando a citação. ID 144536489

Citação ID 144865018, 148725589,

Instada a se contrapor aos substratos fático e jurídico declinados na peça atrial, UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA demandado deduziu na contestação de ID 148483150, argumentando, que cumpriu os requisitos da rescisão contratual determinado pela ANS não havendo ato ilícito a ser averiguado e muito menos indenização por dano moral.

Em petição de ID 150055343, a ACCESS - SUA SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA afirmando que não pode restabelecer o contrato e que o autor no momento da contratação afirmou residir no Rio de Janeiro e tinha ciência que o plano tinha abrangência local e mesmo assim continuou a utilizar, bem como houve comunicação prévia do cancelamento. Afirma também que Administradora não possui mais relação com a Ré Unimed Serrana, visto que estas tiveram seu contrato cancelado.

ACCESS - SUA SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA apresentou contestação de ID 152974242 alegando preliminarmente a ilegitimidade de parte passiva por não ter mais relação com a Operadora Unimed Serrana e daí demostra que não tem como cumprir a liminar. Assevera também que houve a notificação prévia a parte requerente, não havendo falha na prestação do serviço. Afirma também que a parte requerente incorreu em erro, pois informou endereço do Rio de Janeiro, onde não residia e o plano tem ingerência local, não cabendo dano moral e a improcedência total do pedido.

A parte postulante, regularmente intimada, apresentou réplica (ID 157199372), impugnando a contestação em todos os seus pontos, reafirmando os termos esposados na inicial.

Ministério Público manifesta não haver interesse no feito. ID 168408671

As partes foram intimadas para informar o interesse em produzir outras provas (ID 169207548), ocasião em que a parte autora afirmou não possuir interesse em produzir provas, bem como a parte requerida também informou não ter interesse em produzir provas (ID. 171133698, 208183125).

SUA SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA- ACCESS SAÚDE requer o valor dos pagamentos das mensalidades sejam transferidos para a conta indicada. ID 177110578

Parte autora demonstra sua discordância na liberação dos valores. ID 177199382

Informação da parte requerente informando o descumprimento da liminar. ID 208183125

UNIMED NOVA FRIBURGO – COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA afirma não ter condições de cumprir a liminar requerendo a reconsideração. ID 210210245

Despacho determinando o cumprimento da liminar. ID 212119097

UNIMED NOVA FRIBURGO – COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA afirma que o plano se encontra ativo. ID 212324295

Em seguida, os autos me vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente passo a analisar a preliminar suscitada.

Preliminarmente, com efeito, a apuração da legitimidade passiva para um determinado processo se faz por meio da verificação da pertinência abstrata dos sujeitos processuais em relação ao direito material controvertido, conforme disciplina a teoria da asserção. Esse é, inclusive, entendimento pacificado do E. STJ (REsp 1605470/RJ, Terceira Turma, DJe 01/12/2016; REsp 1314946/SP, Quarta Turma, DJe 09/09/2016).

Da análise das assertivas da petição inicial, vislumbra-se mencionada pertinência abstrata, já que sustenta a parte autora que houve o cancelamento unilateral de seu plano de saúde, conduta que configuraria ato ilícito e, portanto, capaz de gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais. Assim, está a demandada legitimada a figurar no polo passivo acionário.

Ademais, a relação jurídica entre as partes litigantes tem natureza de consumo, já que estão presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor - artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor) e objetivos (produto e serviço - §§ 1º e 2º do art. 3º do mesmo dispositivo). A questão está pacificada e cristalizada no enunciado sumular nº 608 do Superior Tribunal de Justiça:

Assim sendo, cumpre destacar a existência de solidariedade entre a operadora do plano de saúde e a administradora dos benefícios, haja vista que ambas integram a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde, nos termos dos artigos 3º, 7º, parágrafo único, e 28, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em questão, a ação foi proposta contra a operadora do plano de saúde UNIMED NOVA FRIBURGO, ora primeira ré, cuja marca foi utilizada pela segunda ré, ACCESS. Observa-se que o autor aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo com as empresas rés, configurando a inequívoca responsabilidade solidária destas decorrente das relações de consumo. Sendo assim rejeito a referida preliminar.

Esse é, inclusive, o entendimento desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RELAÇÃO CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE ESTIPULANTE E OPERADORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa agravante. Rejeição. Teoria da asserção. Responsabilidade solidária entre as rés. Existe solidariedade entre a operadora do plano de saúde e a administradora dos benefícios, já que integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, conforme dispõem os artigos 3º, 7º, parágrafo único, e 28, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. [....] (0051570-83.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 05/09/2024 - DECIMA SETIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26a CÂMARA CÍVEL))

Enfrentadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Impende observar, por relevante, que se acham presentes os pressupostos processuais de existência e de validade, e uma vez estabelecida a lide ante a pretensão resistida, em face da dialética processual à vista das alegações das partes litigantes, para correta compreensão da controvérsia, é possível o exercício da Atividade Jurisdicional para resolução do conflito.

O Código de Processo Civil (CPC) permite ao magistrado, quando a matéria for unicamente de direito, ou de fato e de direito, mas sobejamente comprovada nos autos, o julgamento antecipado da lide. Pois bem, sendo o presente caso um dos elencados pelo CPC, passo ao imediato julgamento do feito, uma vez que seu conhecimento independe de provas produzidas em audiência e a prova pericial também não se faz necessária.

Presentes, pois, os pressupostos processuais e as condições da ação, passo desde já ao exame do mérito da lide, porquanto está apta a receber julgamento antecipado, visto que a matéria nela versada é unicamente de direito e os fatos estão suficientemente comprovados pelos documentos juntados (art. 355, I do Código de Processo Civil).

Trata-se de ação na qual pretende a parte autora ser reincluída nos quadros de beneficiários do plano de saúde da ré, bem como ser indenizada pelos danos morais sofridos.

O dever de reparação, destarte, surge após a devida comprovação do fato antijurídico, do dano causado à vítima, bem como do liame causal entre o ato ilícito e o dano, uma vez que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Ausente qualquer desses requisitos, resta inviável o acolhimento da pretensão indenizatória.

Na espécie, sustenta o demandante que teve o seu plano de saúde cancelado de forma unilateral e só teve conhecimento através da notificação por e-mail (ID 144499046)

Neste contexto, é oportuno ressaltar as disposições trazidas pelo artigo 13 da Lei nº 9.656/1998, responsável por disciplinar os critérios para suspensão e rescisão unilateral dos planos privados de assistência à saúde:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

A norma em referência é taxativa ao proibir, por iniciativa da operadora, tanto a suspensão de cobertura quanto a rescisão unilateral imotivada do plano privado de assistência à saúde individual ou familiar.

Os planos de saúde coletivos, por sua natureza, são regulados por normas próprias e distintas daquelas aplicáveis aos planos individuais e familiares. Tais planos podem ser suspensos ou rescindidos de forma imotivada, desde que cumpridos os requisitos previstos na Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009, quais sejam: (i) existência de cláusula contratual que preveja tal prerrogativa para ambas as partes; (ii) decurso de, no mínimo, doze meses da vigência do contrato; e (iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias, in verbis:

Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Embora a aplicação do artigo 13 da Lei nº 9.656/1998 se limite aos planos de saúde individuais ou familiares, prevalece o entendimento de que a vedação à rescisão contratual durante a internação do usuário - ou enquanto este estiver submetido a tratamento médico indispensável à sua sobrevivência ou à preservação de sua integridade física - também se estende aos planos coletivos.

Assim sendo, nas hipóteses de o usuário estar internado ou em tratamento de saúde, a operadora, ainda que tenha exercido seu direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica. Esse

entendimento é alcançado pela interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, b, e 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do art. 16 da Resolução Normativa DC/ANS 465/2021:

Lei n. 9.656/1998

Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

[...]

§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

[...]

b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento;

[...]

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

[...]

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.

Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021

Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritonial, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa n. 259, de 17 de junho de 2011.

Parágrafo único. O procedimento "Medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos" é considerado como continuidade dos procedimentos de quimioterapia e terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer, não cabendo nova contagem ou recontagem de prazo de atendimento para aquele procedimento.

A interpretação mencionada está igualmente respaldada pela boa-fé objetiva, pela segurança jurídica, pela função social do contrato e pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Logo, mesmo nas hipóteses de motivação legítima, a suspensão de cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não deve acarretar risco à preservação da saúde ou vida do usuário que se encontre em situação de vulnerabilidade.

Nos casos de usuários internados ou submetidos a tratamentos garantidores de sua sobrevivência ou manutenção de sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes.

Nessa mesma direção posicionou-se o C. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a seguinte tese jurídica:

Tema Repetitivo 1.082: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

A referida tese firmada no âmbito dos recursos repetitivos tem sido reiteradamente aplicada por esta E. Corte para solucionar litígios análogos aos ora analisados nos presentes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA IRRESIGNAÇÃO DO BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE, PORTADOR DE TEA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1082, FIXOU A TESE DE QUE A OPERADORA, MESMO APÓS O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO, DEVERÁ ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS PRESCRITOS A USUÁRIO INTERNADO OU EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA, DESDE QUE O TITULAR ARQUE INTEGRALMENTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO (MENSALIDADE) DEVIDA . O ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 DA ANS, VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, QUE ESTABELECE QUE OS CONTRATOS DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVOS POR ADESÃO OU EMPRESARIAL SOMENTE PODERÃO SER RESCINDIDOS IMOTIVADAMENTE APÓS A VIGÊNCIA DO PERÍODO DE DOZE MESES E MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA OUTRA PARTE COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE SESSENTA DIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, EM ESPECIAL, O PERIGO DE DANO, UMA VEZ QUE O BENEFICIÁRIO É MENOR DE IDADE, COM APENAS 5 ANOS, E NECESSITA DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO TENDO EM VISTA QUE É PORTADOR DE TEA E, ALÉM DAS DIVERSAS TERAPIAS, FAZ USO DE MEDICAÇÃO IMPORTADA (CANABIDIOL 20MG/ML) HAVENDO RISCO À SAÚDE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (0051473-83.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA - Julgamento: 03/09/2024 - OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17a CÂMARA CÍVEL)) Grifou-se.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUTOR (8 ANOS DE IDADE) QUE É BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE RÉU DESDE 2022. PESSOA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), TAMBÉM CHAMADO DE NEURODIVERGENTE, E, PORTANTO, HIPERVULNERÁVEL. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. E-MAIL RECEBIDO NOTICIANDO QUE O PLANO SERIA CANCELADO. DEFERIMENTO DA TUTELA PARA DETERMINAR QUE O RÉU RESTABELEÇA O PLANO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO, SEM PREVISÃO DE ALTA MÉDICA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO DESDE QUE CUMPRIDOS 3 REQUISITOS: I) CLÁUSULA EXPRESSA

PREVENDO A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL; II) CONTRATO EM VIGÊNCIA POR PERÍODO DE PELO MENOS 12 MESES; E III) ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. OCORRE QUE, NO CASO DOS AUTOS, HÁ UMA PECULIARIDADE QUE ENSEJA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MATERIALIZADO NO TEMA REPETITIVO 1.082: "A OPERADORA, MESMO APÓS O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO, DEVERÁ ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS PRESCRITOS A USUÁRIO INTERNADO OU EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA, DESDE QUE O TITULAR ARQUE INTEGRALMENTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA." LAUDO MÉDICO INDICANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) QUE É CONDIZENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONTUDO, DEVE SER FIXADO O TETO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. LIMITAÇÃO DA MULTA QUE SE FAZ DE OFÍCIO. (0047918-58.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES - Julgamento: 29/08/2024 - DECIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14a CÂMARA CÍVEL)). Grifou-se.

Na espécie, restou demonstrado que o autor é portador de autismo, necessitando de tratamento conforme laudo (ID 144493951). A parte autora começou o referido tratamento enquanto ainda vigente o contrato em análise, pois contratou em setembro de 2022 e o tratamento iniciou em 2023, e ainda não obteve alta, persistindo, portanto, a necessidade de tratamento para garantir sua incolumidade física.

Nesse contexto, apesar de a rescisão contratual entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios ora rés ter sido realizada em conformidade com as exigências legais - já que há cláusula contratual que prevendo tal possibilidade, assim como o decurso de doze meses da vigência do contrato e a prévia notificação do beneficiário -, não se revela possível, conforme a jurisprudência das cortes superiores e deste E. Tribunal, a rescisão na hipótese dos autos.

Conclui-se, consequentemente, que o cancelamento unilateral do plano de saúde do autor, enquanto este necessitava da continuidade de seu tratamento, revela-se indevido. Por essa razão, mister o reconhecimento da falha no serviço prestado pela ré e o acolhimento do pleito indenizatório.

Isso porque a privação do serviço de saúde e a angústia suportadas pelo autor com a interrupção do plano, principalmente quando esse necessitava da manutenção de seu tratamento para ter uma qualidade de vida mínima, extrapolam a esfera do mero aborrecimento e, inegavelmente, são suscetíveis de indenização por dano moral.

Trata-se, na verdade, de dano moral in re ipsa , que decorre do próprio fato e independe de comprovação do abalo psicológico. É nesse sentido, inclusive, que este E. Tribunal vêm decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA DOS PEDIDOS, DETERMINANDO QUE A RÉ, ORA APELANTE, REATIVE O PLANO DE SAÚDE DA AUTORA, BEM COMO CONDENANDO A OPERADORA NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELO DA OPERADORA, ARGUMENTANDO QUE A RESPONSABILIDADE PELO RECEBIMENTO DA FATURA É APENAS DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, QUE TERIA NOTIFICADO A BENEFICIÁRIA ACERCA DE EVENTUAL PENDENCIA DE DOCUMENTOS QUE INVIABILIZOU A CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE QUE, EM RAZÃO DA PARCERIA COMERCIAL EXISTENTE ENTRE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, O QUE GERA AUMENTO DA CLIENTELA E DOS LUCROS OBTIDOS, A EMPRESA QUE OFERECEU O PLANO À DEMANDANTE E A ADMINISTRADORA FAZEM PARTE DA CADEIA DE CONSUMO, RESPONDENDO SOLIDARIAMENTE PELA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS A CONSUMIDORA, NOS EXATOS TERMOS DOS ARTIGOS 7º. PARÁGRAFO ÚNICO E 25º, § 1º DO CDC. INEXISTENCIA NOS AUTOS DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DIRECIONADA A USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE, CIENTIFICANDO- A, COM CLAREZA, ACERCA DA NECESSIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS QUANTO A SUA ELEGIBILIDADE PARA O CONTRATO. USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE QUE, DIAGNOSTICADA COM TROMBO EMBOLIA PULMONAR, FAZIA TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE, COM USO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO E REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA TRÊS VEZES NA SEMANA, ALÉM DE UMA VISITA MÉDICA SEMANAL. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1082 DO C. STJ NO SENTIDO DE QUE A OPERADORA, MESMO APÓS RESCINDIR UNILATERALMENTE O PLANO OU O SEGURO DE SAÚDE COLETIVO, DEVE GARANTIR A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA A BENEFICIÁRIO INTERNADO OU EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE, ATÉ A EFETIVA ALTA, DESDE QUE ELE ARQUE INTEGRALMENTE COM O VALOR DAS MENSALIDADES . INEGÁVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (0814520-97.2023.8.19.0202 - APELAÇÃO. Des (a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA - Julgamento: 18/07/2024 - SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA CÍVEL)) Grifou-se.

Preenchidos os requisitos da reparação civil, cumpre-nos fixar o quantum compensatório e, para isso, devem-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a fim de que a reparação pecuniária não constitua fonte de enriquecimento sem causa por parte da autora.

Ademais, imperioso observar o caráter punitivo da sanção, como fator de desestímulo ao agente (teoria do valor do desestímulo), evitando-se a prática de novos atos lesivos.

É o que entende Carlos Alberto Bittar:

"Nesse sentido é que a tendência manifestada, pela jurisprudência pátria, é a da fixação de valor de desestímulo como fato de inibição a novas práticas lesivas. Trata-se, portanto, de valor que, sentido no patrimônio do lesante, o possa fazer conscientizar-se de que não deve persistir na conduta reprimida, ou então deve afastar-se da vereda indevida por ele assumida. De outra parte, deixa-se, para a coletividade, exemplo expressivo da reação que a ordem jurídica reserva para infratores nesse campo, e em elemento que, em nosso tempo, se tem mostrado muito sensível para as pessoas, ou seja, o respectivo acervo patrimonial." (in Carlos Alberto Bittar, "Reparação Civil por Danos Morais: a Fixação do Valor da Indenização", JTACIVSP, vol. 147/9).

Considerados tais elementos, aliados ao arbitramento de quantia equânime e suficiente de tal maneira a desestimular novas condutas por parte das rés, a compensação por danos morais deve ser arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da publicação da sentença, conforme enunciado sumular de n. 362 do STJ, e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Ressalto que as formalidades legais atinentes à espécie foram cumpridas e o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 - Info 585.

I - DISPOSITIVO

PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

I- DETERMINAR que a ré restabeleça o plano de saúde do autor, tornando definitiva a decisão do ID 144536489. **Determinar que a parte requerida mantenha o plano de saúde do requerente, com a continuidade do seu tratamento junto à clínica RN (Centro de Reabilitação Neurológica) de Caruaru/PE, com a disponibilização de todos os boletos para o pagamento do plano; ou realize a portabilidade do requerente para um plano de saúde, com abrangência nacional, seja UNIMED SERRANA RJ ou outra UNIMED com abrangência nacional, nas mesmas condições de preço, abrangência e demais, sem necessidade de qualquer período de carência, plano esse que permita o requerente continuar os tratamentos necessários junto a clínica CRN (Centro de Reabilitação Neurológica) de Caruaru;**

II- CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pela tabela ENCOGE – a partir da publicação da presente sentença – e acrescido de juros legais de mora, a partir da citação, – a serem calculados com base na SELIC.

Condeno as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios do demandante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Havendo recurso de apelação de qualquer das partes, determino desde já que se intime a parte contrária para contrarrazões, remetendo-se em seguida ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, independente de novo despacho (art. 1.010, §3º, do CPC).

Decorrido o prazo sem recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se**. Após o trânsito em julgado** expeça-se alvará das mensalidades pagas a UNIMED NOVA FRIBURGO – COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

São Joaquim do Monte, 02/12/2025.

VALDELÍCIO FRANCISCO DA SILVA

Juiz de Direito em exercício cumulativo

Assinado eletronicamente por: VALDELICIO FRANCISCO DA SILVA
03/12/2025 09:14:24
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 224773193

25120309142442400000218706079

IMPRIMIR GERAR PDF